

✦ Пространство новых идей 2.0

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ · МИНТРУД РОССИИ

Не просто накормить

Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания

Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года · директора и специалисты учреждений из 51 региона

Докладчик: Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» · доклад, 285 стр., 121 источник

Презентация не дублирует доклад — она задаёт вопросы, к которым доклад даёт инструменты

Кто в вашем учреждении в действительности выбирает, что сегодня будет есть житель?

он сам · санитар · врач

кухня · контрактный управляющий · региональная норма

Поднимите руку на своём варианте. Отвечаем честно — это не проверка, а исходная точка, от которой считается путь.

Ответ проверяется не словами, а вчерашним журналом

Что отвечают на семинарах

«У нас спрашивают жителей»

«Диетсестра всё учитывает»

«Меню утверждает регион — мы не вправе»

«Жители сами не знают, чего хотят»

Что показывает проверка фактов

Спрашивают — но готовят одно

Выбор не зафиксирован ни в одном журнале

Таблица замен существует, но ею пользуется кухня,
а не житель

Не выбирают — потому что давно не спрашивали

Три контрольных вопроса ставят учреждение на ступень лестницы без субъективности — покажем их через несколько слайдов.

Один обед, который знает каждый

12:30. Тележка выходит из кухни. Первое отделение получает еду горячей.

12:55. Третье отделение. Суп тёплый. Котлета остыла.

13:10. Последний стол. Житель, который не ест гречку с детства, смотрит на гречку. Ест два ложки. Тарелка уходит в отходы.

18:00. Ужин. Следующий приём пищи — завтрак в 8:30.

В этом обеде нет нарушений. Меню утверждено, нормы соблюдены, журналы заполнены.

И при этом житель остался голодным, еда остыла, а ночной интервал составил четырнадцать с половиной часов.

Шесть измерений — вместо мнений о столовой

1. Температура на последнем столе — не на выходе из кухни. Один замер термометром.

2. Остатки на тарелках — ведомость: какие блюда остаются чаще половины порции. Пять цифр в день.

3. Отказы — журнал: кто отказался, что получил взамен, три подряд — сигнал врачу.

4. Ночной интервал — фактическое время ужина и завтрака, три дня подряд.

5. Доля выбравших — сколько жителей вчера получили не то, что принесли бы по умолчанию.

6. Срывы — журнал: закончился ли вариант Б до последнего отделения.

Общее правило: измеряется факт — температура на столе, остаток на тарелке, интервал в часах, — а не запись о факте.

Три цифры, которые меняют разговор

~15 ч

ночной интервал между ужином и завтраком в типовом замере — при норме зарубежных протоколов 11–14 часов

44→90%

рост соблюдения стандартов текстур после внедрения единой шкалы IDDSI; по жидкостям — с 31% до 100%

+6,1

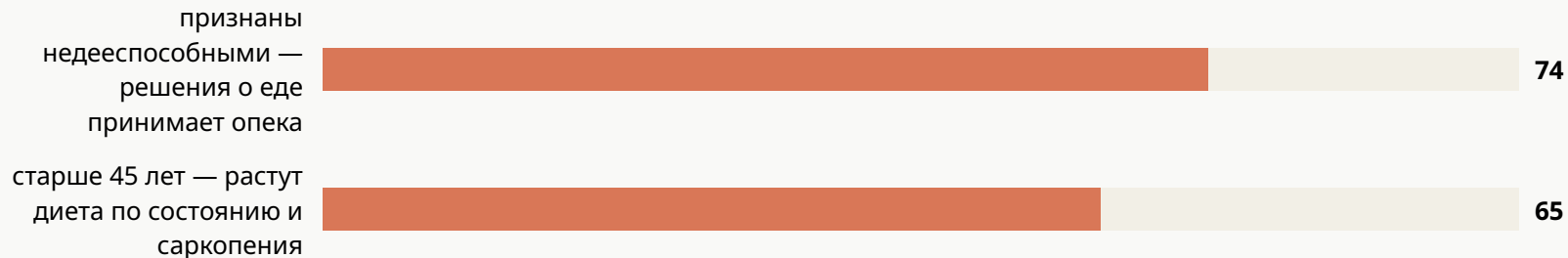
балла качества жизни в РКИ «семейной подачи» у пожилых с деменцией; плюс +1,5 кг веса и +991 кДж/день

Первая цифра — ваша: измеряется в вашем доме за три дня. Вторая и третья — из опубликованных исследований:

организация еды влияет на потребление, а потребление — на вес и качество жизни. Это цепочка данных, а не

Две цифры о контингенте, которые решают дизайн стола

Доля жителей, %



Три четверти решений о еде принимает не сам житель — поэтому выбор оформляется через опекуна и врача, а не «вопросом за столом».

Сколько часов житель не ест: от ужина до завтрака



Значение для РФ — **оценка по типовым графикам учреждений**, а не статистика: репрезентативных данных нет.

Ваша цифра измеряется за три дня — и почти всегда отличается от графика на бумаге.

Что с этим делать без денег: поздний перекус для групп, которым он показан (список — с врачом), сдвиг ужина внутри существующего распорядка, контроль фактического времени подачи, а не расписания.

Четыре вещи, которые путают, — и почему это дорого

Цикличное меню

Повторяющийся цикл блюд (14 дней по нашим раскладкам). Про разнообразие во времени — **не про выбор**.

Замена по таблице

Эквивалентная замена продуктов в раскладке. Делает вариативность законной — но сама выбором жителя **не является**.

Персонализация

Индивидуальные назначения вне общего выбора: текстуры, ограничения, усиленное питание. Назначает **врач**.

Вариативное меню

Житель в момент приёма пищи имеет **реальную возможность получить не менее двух вариантов** и влияет на то, какой получит.

Типовая ошибка: «у нас 14 дней без повторов — вот и вариативность» или «мы заменяем гречку на рис — вот и выбор».

Лестница вариативности: не пропасть, а шесть ступеней

Ступени 1–2 подтверждены действующими российскими практиками —
это реалистичный горизонт большинства участников семинара на ближайший год



Источник: раздел 8.2 доклада; подтверждённые практики ступеней 1–2 — Болотнинский и Успенский ПНИ, Иркутская область (сайты учреждений, 2026); ступень 4 — Nijs et al., 2006; ступени 3 и 5 — применимы выборочно/на горизонте

Ступени 0 и 1: старт без новых денег

Ступень 0. Мономеню с учётом отказов

Выбора ещё нет, но:

- отказ от блюда влечёт **замену по таблице**, а не пустую тарелку;
- остатки разбираются и **влияют на цикл меню**;
- журнал отказов фиксирует три отказа подряд — сигнал врачу.

Это фундамент: американская федеральная норма требует альтернативу при отказе как базовый минимум.

Ступень 1. Два варианта одной позиции

Каша А / каша Б на завтрак, несколько раз в неделю — **подтверждённая конфигурация старта** (Болотнинский ПНИ).

Перечень определяет диетсестра, заказ — накануне через журнал.

Цена: одна вторая гастрорёмкость + одна страница журнала в день.

Новых денег при парных эквивалентах практически нет; **новый труд** — есть, и он называется честно.

Вопрос не «вводить ли вариативность», а «какая ступень нам по силам в этом году».

Ступени 2–5: куда расти после пилота

2. Выбор по всем основным позициям ежедневно. Подтверждено: Успенский ПНИ (все отделения) и региональная модель Иркутской области. Требуется отлаженный журнал заказа и пересчёта объёмов по статистике выбора.

3. Выбор на линии раздачи. Буфетная зона салатов, напитков, десертов. Больше выбора — больше требований: площадь, скорость потока, санитарный контроль открытых блюд. Применима выборочно.

4. Семейная подача за столом. Общие блюда, жители накладывают сами. Доказанный эффект у пожилых с деменцией (качество жизни, вес, энергопотребление). Точно, там, где рассадка позволяет.

5. «Своя кухня». Жители готовят сами при поддержке персонала. Горизонт квартир тренинга жизненных навыков и подготовки к сопровождаемому проживанию.

Ступени не перепрыгивают: каждая следующая опирается на журнал и статистику предыдущей.

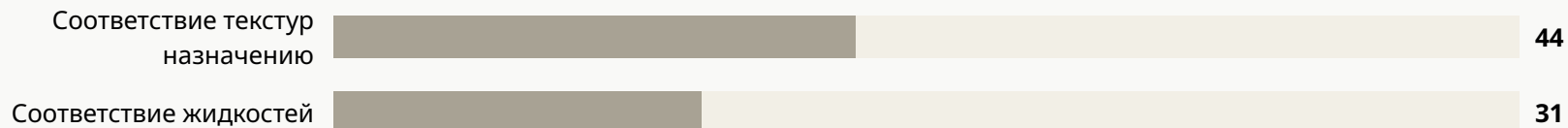
Пять критериев отсекают формальную «вариативность»

- 1. Доступность.** Вариант Б физически существует, когда подходит житель, — а не «закончился к первому отделению».
- 2. Равноценность.** Варианты эквивалентны по питательной ценности — замена по таблице, а не «гречка или ничего».
- 3. Информированность.** Житель знает о выборе и понимает его доступным способом: слово, показ, визуальное меню.
- 4. Уважение.** Выбранное реально подаётся; переубеждать «для вашей пользы» — не норма.
- 5. Учёт.** Выбор фиксируется и влияет на завтрашние объёмы готовки и будущие циклы меню.

Проверка любой ступени — пятью вопросами к вчерашнему дню. Не к положению на бумаге — **к вчерашнему дню.**

Единая шкала IDDSI: соответствие выросло вдвое

До единой шкалы, %



Изменение достигнуто именно обучением, а не оборудованием: та же кухня, те же продукты — другая точность.

Подтверждено: шесть действующих российских практик

Болотнинский ПНИ (Новосибирская обл.) — выбор из двух вариантов на завтрак и обед несколько раз в неделю; перечень определяет диетсестра. *Степень 1.*

Успенский ПНИ (Новосибирская обл.) — выбор по всем основным позициям, ежедневно, все отделения. *Степень 2.*

Усть-Илимский ДСО (Иркутская обл.) — поэтапно, с опроса; участник семинара.

Серафимовский ДСО (Санкт-Петербург) — заказ накануне для части жителей; оборудование и доп. сотрудники; полный переход затруднителен. *Дом докладчика.*

Иркутская область — масштабирование на регион: два первых, два вторых, гарниры — ежедневно.

ДДСОЛ — 14-дневное меню плюс совет по питанию из жителей.

Новость — факт сообщения, не аудит. Три кейса стартовали без новых денег; Серафимовский публично назвал оборудование, ставки и пределы полного перехода.

Болотнинский ПНИ: выбор начинается накануне

Как устроено

- Диетсестра определяет пару вариантов из таблицы замен — эквиваленты по питательной ценности;
- за день до приёма пищи смена обходит отделения и записывает заказ каждого жителя;
- кухня готовит по журналу заказа, а не «поровну наугад»;
- несколько раз в неделю, завтрак и обед — не «всё и сразу».

Что забрать себе

Заказ накануне снимает главный страх директоров — срыв раздачи: бороться на линии не за что, каждому приготовлено его.

Старт с одной позиции, а не с полного меню.

Обсуждение в малых группах: какая позиция в вашем меню — кандидат на первую пару?

Кто у вас будет вести журнал заказа, и кто его подменяет?

Успенский ПНИ: выбор по всем позициям ежедневно

Как устроено

- Два варианта первых, вторых, гарниров и напитков — ежедневно, на всех отделениях;
- заказ — через журнал, как на ступени 1, но по полной линейке;
- объёмы готовки пересчитываются по накопленной статистике выбора;
- работает в действующих лимитах финансирования.

Что забрать себе

Статистика выбора — главный актив ступени 2: через две недели журнал сам говорит, в какой пропорции готовить.

Масштаб учреждения — не препятствие: это вопрос логистики журнала.

Для разговора с учредителем: Иркутская область показала, что ступень 2 масштабируется до регионального стандарта — два варианта первых и вторых, гарниры ежедневно, на сеть учреждений.

Япония: от доплаты до обязательного стандарта

Госпитализации, %



16 лет регуляторного пути

2005 — доплата за нутритивный менеджмент

2020 — охват 87–94 % учреждений

2021 — обязательный стандарт с вычетом за неисполнение и сдачей данных в базу LIFE

Связка «доплата → охват → стандарт» дала измеримый эффект: меньший риск ухудшения уровня ухода (HR 0,90).

Слева — разница в госпитализациях между одним и двумя управляющими диетологами. Оговорка доклада: не РКИ, используется как порядок величин.

У кого в учреждении житель вчера выбирал, что есть?

В этом зале сидят директора учреждений, где вариативность уже работает, — Успенский, Усть-Илимский и Серафимовский (дом докладчика). Расскажите залу одну минуту: **что именно выбрал ваш житель вчера?**

Лучшие ответы на трудные вопросы этого семинара дают не слайды, а сидящие рядом коллеги.

Журнал заказа: пять шагов против срыва раздачи

1. Заказ

смена обходит
отделения накануне

2. Журнал

одна страница: кто
что выбрал

3. Готовка

по заказу плюс
небольшой резерв

4. Раздача

каждому — его
заказанное

5. Статистика

две недели → новые
пропорции

Выбор делается **накануне, а не на линии** — поэтому конфликт «кому достанется лучший вариант» не возникает: бороться не за что, каждому приготовлено его заказанное.

Остаточные срывы фиксируются в журнале срывов и чинят пропорции готовности. Вопрос не «будут ли срывы», а «записываются ли».

Две недели заказов — и пропорции готовности меняются

Блюдо А (основное)



Иллюстративный пример заполнения формы: заказ накануне показывает реальный спрос, и пропорции готовности корректируются по журналу, а не по привычке.

Парные эквиваленты: два блюда из одного сырьевого

Один сырьевой набор

говядина по раскладке, та же
закупка, та же мясорубка, та
же смена

Вариант А

гуляш с гречкой

Вариант Б

гуляш с рисом

Оба варианта заранее вписаны в таблицу замен как эквиваленты — юридически житель получает блюдо по раскладке.

Приращение: одна гастрорёмкость, одна страница журнала. Приращения сырья — нет.

Отходы при этом чаще **снижаются**, а не растут: житель ест выбранное, а не обязательное.

Это утверждение проверяется в каждом доме собственной ведомостью остатков — а не принимается на веру.

Что почём на каждой ступени: деньги, труд, документы

Ступень	Новые деньги	Новый труд	Ключевые документы
0. Учёт отказов	нет	ведомость остатков, журнал отказов	таблица замен, журнал отказов
1. Два варианта позиции	практически нет (парные эквиваленты)	одна гастрорёмкость, одна страница журнала в день	+ журнал заказа, приказ о пилоте
2. Все позиции ежедневно	посуда и логистика (термоконтейнеры)	пересчёт объёмов по статистике	+ журнал срывов, квартальная панель
3–5. Линия, семейная подача, своя кухня	зонирование, мебель, оборудование — по смете	смена роли персонала	согласование с учредителем и врачом

Вариативность не «почти бесплатна»: трудозатраты реальны и названы. Бюджетных затрат на ступенях 0–1 нет — это подтверждено действующими практиками.

Контракт как место вариативности: 8 строк

Кухня на аутсорсинге — не конец выбора, а его новое место. Если этих строк нет в спецификации, вариативность невозможна вне зависимости от желания директора.

- | | |
|---|--|
| 1. Группы взаимозаменяемых позиций вместо монопозиций | 5. Качество текстур в спецификации — дисфагия не заложник «дешёвого фарша» |
| 2. Пропорции по статистике выбора, корректировка раз в квартал | 6. Приёмка и суточные пробы — по п. 56 СанПиН (подп. 12, отбор — подп. 4) |
| 3. Не менее двух вариантов основных позиций; срыв выбора ≠ исполнение | 7. Меню-цикл с раскладкой — приложение к контракту, сверка с 520н |
| 4. Замены при недопоставке — эквивалент из той же группы, акт | 8. Ежемесячная отчётность: доля выбора, остатки — в панель чисел |

Красная линия: исполнение контроля качества можно делегировать поставщику — ответственность перед жителями и проверяющими остаётся у учреждения.

Документный контур: процедура вместо оправданий

Приказ

о пилоте: 90 дней,
ответственный

Положение

о вариативном меню

Таблица замен

оба варианта —
эквиваленты

Журнал заказа

выбор зафиксирован
вчера

Панель

квартальные числа
результата

Юридически житель получает блюдо по раскладке — **из заранее оформленного ряда эквивалентов.**

Таблица замен продуктов — действующий механизм, существующий десятилетиями, а не изобретение пилота.

Честно: риск формального подхода у проверяющих существует и практика неоднородна. Он снижается контуром документов, построенным заранее, — а не отказом от выбора.

Решение о судьбе пилота после проверки принимается по факту её выводов — а не по страху до неё.

1 сентября, 7 утра: что открыть

Семинар — последняя неделя 3590-20. С 01.09.2026 действует 4282-26 полностью: переходного периода нет. Модель выбора не меняется. Меняются формы.

Делать с утра 1 сентября

1. Открыть журналы бракеража по приложениям 4 и 5 нового СанПиН
2. Вести пробы каждого варианта отдельно
3. Держать ППК в актуальной редакции
4. Температуру на линии — по технологическим картам

Не делать

1. Не переписывать августовские журналы «под новые формы»
2. Не считать сентябрь «месяцем привыкания»
3. Не останавливать выбор: обе редакции его не запрещают
4. Не отдавать суточные пробы только поставщику

Проверка в сентябре смотрит сентябрь по новым правилам и август по старым. Чек-лист — приложение 39.

Два варианта на подносе, не вторая линия

Столовая закрыта или житель не выходит на линию — выбор меняет форму, а не исчезает. Одиннадцать процентов жителей постельные или маломобильные. Для них линия — чужой мир.

Как выглядит выбор в комнате

1. Две порции на подносе или картинки на двери
2. Стандартный вариант всегда есть
3. Журнал заказа — на посту
4. Горячее доходит до палаты: замер на последней выдаче

План Б до вспышки, не утром

1. Кто готовит, если не вышла кухня
2. Питьё по графику, отдельная посуда
3. Витаминизация — только врач
4. Лица на фото линии не попадают

Если вариативность есть только в столовой — это привилегия ходячих. Форма плана Б — приложение 45.

Четыре опоры, на которых стоит вариативность

442-ФЗ, ст. 9 и 32

Права получателя соцслужб (ст. 9); плата за стационар ограничена 75% среднедушевого дохода (ст. 32) — вариативность **без доплат**.

Приказ Минтруда № 520н

Действующие рекомендуемые нормы питания (заменил 552н). Норма — раскладка, внутри которой действует таблица замен.

СанПиН 3590-20 → 4282-26 с 01.09.2026

На семинаре действует 3590-20 (п. 7.1.11–7.1.14); с 1 сентября — п. 56(11) 4282-26: те же ≥ 3 приёмов и диета по показаниям.

Таблица замен к меню-раскладке

Механизм эквивалентной замены продуктов — **легальный канал вариативности, существующий десятилетиями**.

Вывод юридического раздела доклада: **вариативность не требует изменения закона** — она требует грамотного использования действующих механизмов и документального контура.

Дисфагия: скрытая причина отказов от еды

Признаки, которые видит смена

- кашель или поперхивание за едой;
- влажный, «булькающий» голос после глотка;
- приём пищи дольше 40 минут;
- еда за щекой, недоеденные порции, отказ от плотной пищи.

Смена **распознаёт и сообщает** — заключение делает врач.

Что показывают данные

Дисфагия распространена у жителей учреждений и недодиагностирована: опубликованные оценки — в широком диапазоне (реестр доклада), репрезентативных российских данных нет.

После внедрения единой шкалы текстур IDDSI соблюдение стандартов выросло с 44% до 90%.

Организационный минимум: список жителей с трудностями еды — единый у врача, диетсестры и отделений; текстуры — только по назначению врача; три отказа подряд — сообщение врачу в тот же день.

Полость рта · стакан воды · стул

РОТ

РКИ домов ухода, n=366: щётка после еды, часто повидон-йод, стоматолог раз в неделю → пневмонии 11 % vs 19 %. ~1 из 10 смертей — Sjögren в обзоре Müller (J Dent Res). Группа зависимости, не «две минуты на всех».

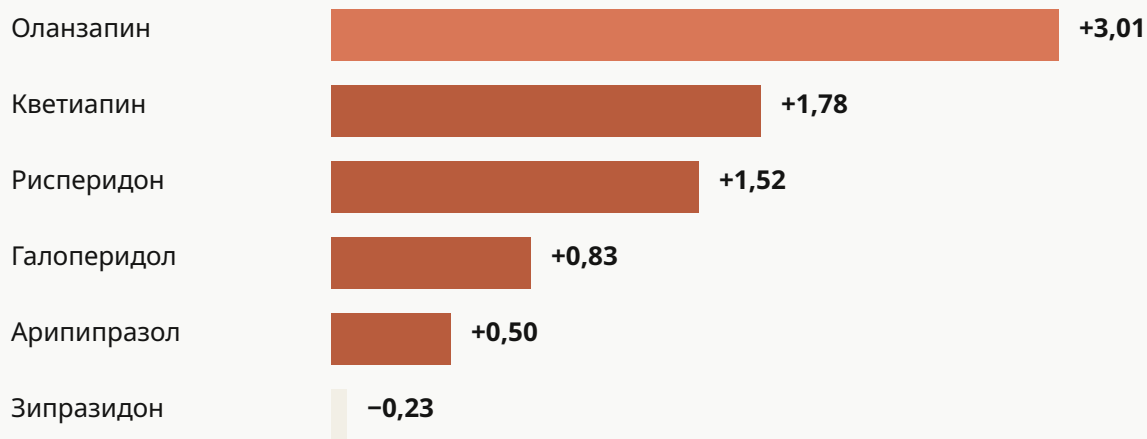
СТАКАН

Загущённые напитки доказанно снижают потребление жидкости; данных о снижении осложнений — нет. Замер: «выпито за сутки» в панели чисел; чайная пауза как шестое событие; индикаторы дегидратации на посту.

СТУЛ

Запор у 30–60 % на клозапине (до 80 % по объективным тестам); тяжёлый — фатален (илеус, перфорация). Да/нет за сутки в постовом журнале (152-ФЗ); 3 суток без стула — врач сегодня.

Среднее изменение массы тела за 6 недель терапии, кг



Вес жителя — не только про кухню: терапия сдвигает его сильнее любого меню. Поэтому взвешивание и триггеры (протоколы используют ступени **5 / 7,5 / 10%** массы тела за фиксированные периоды) — клинический минимум, а лекарственно-пищевая таблица утверждается врачом, а не диетсестрой.

У скольких пациентов вес вырастет клинически значимо

Пациенты со значимой прибавкой, %



Это не «редкая реакция», а плановый риск: мониторинг веса и таблица замен меню прописываются заранее, до первой прибавки.

Что решает врач — и что директор

Врач решает

- текстуры и загущённые жидкости;
- скрининг дисфагии и его пороги;
- триггеры веса и действия по ним;
- усиленное питание и смеси;
- лекарственно-пищевая таблица;
- кому выбор доступен и в каком формате;
- оценка систематического отказа от еды;
- слабительные и реакция на запор (клозапин);
- микронутриенты и сдвиг еды при инсулине;
- MUST / потеря веса — не путать с набором;

Всё, что затрагивает здоровье конкретного жителя, делается **по назначению врача и фиксируется в документах**, а не в договорённостях.

Нарушение этого правила — главный способ скомпрометировать вариативность.

Директор решает

- оборудование для текстур и закупка загустителей;
- журналы, ведомости, приказ о мониторинге;
- единый список трудностей с едой в трёх службах;
- организация позднего перекуса по списку врача;
- график совета по питанию;
- обучение смен распознаванию признаков.

Житель отказался от еды: что происходит дальше

Отказ зафиксирован в журнале

Разовый отказ

замена по таблице — житель не остаётся голодным

Три отказа подряд

сообщение врачу в тот же день — это симптом, а не каприз

Массовый отказ от блюда

разбор на совете → замена в цикле меню

Если тарелка уходит в отходы без записи — учреждение не видит ни голодающего жителя, ни масштаба проблемы.

Журнал отказов — бесплатный инструмент ступени 0 и клинический сигнал одновременно.

Экспресс-аудит: десять вопросов про ваш вчерашний день

1. Вчера житель мог выбрать между двумя вариантами хотя бы одного блюда
2. Этот выбор зафиксирован документально
3. Второй вариант дошёл до последнего отделения
4. Отказ повлёк замену, а не пустую тарелку
5. Руководство ело еду жителей за последний месяц — на столе жителей
6. Ночной интервал известен точно и не превышает 13 часов
7. Остатки на тарелках вчера кто-то посмотрел
8. Температура на последнем столе известна
9. Список «кому трудно есть» совпадает у врача, диетсестры и отделений
10. Меню за квартал менялось по итогам мнения жителей

Шкала

0–3 — степень 0 или ниже

4–6 — элементы есть, системы нет

7–8 — степень 1–2, уязвимая

9–10 — система работает

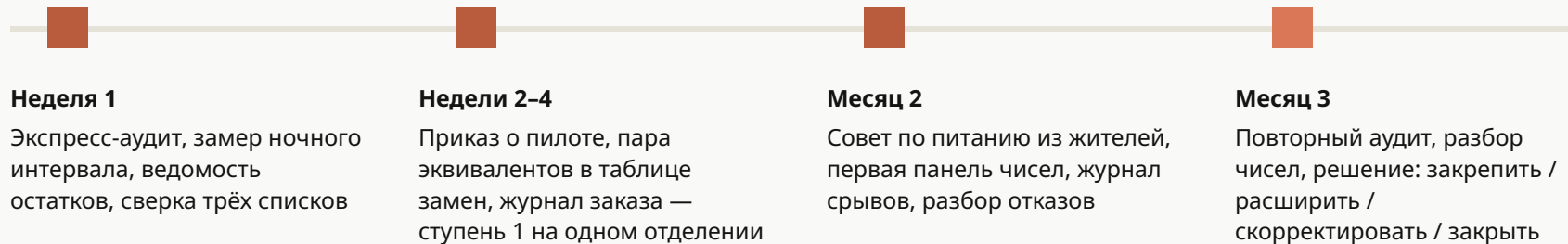
Правило: отвечаем про вчерашний день; «не знаю» честнее «да».

По памяти аудит завышает результат на 1–2 балла — на месте повторить с журналами.

Через 90 дней пилота аудит повторяется — разница баллов и есть главный показатель перед учредителем.

Пилот на 90 дней: одно отделение, одна позиция

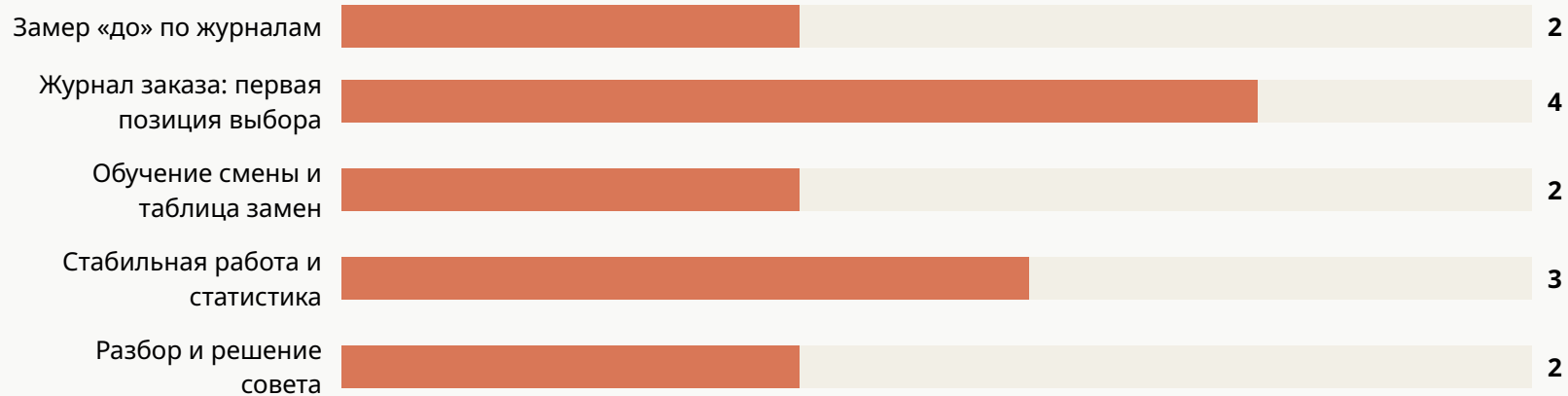
Пилот — не «внедрение вариативности», а **эксперимент с точками замера**: входные числа до старта, те же числа через 90 дней.



У пилота четыре честных исхода, включая «закреть»: если числа не подтвердили пользу — это тоже результат, и доклад объясняет, как его оформить, чтобы не потерять доверие учредителя к следующей попытке.

Пилот по неделям: когда замер, когда решение

Неделя



Тринадцать недель $\approx$ 90 дней. Каждый этап заканчивается точкой честной остановки — и это тоже результат пилота.

Квартальная панель: один лист против регресса

Показатель	Откуда берётся	Что означает падение
Доля выбравших вариант Б	журнал заказа	выбор стал декоративным
Доля замен по отказам	журнал отказов	отказ снова = пустая тарелка
Записи в журнале срывов	журнал срывов	пустой журнал = перестали записывать, а не срывать
Остатки по блюдам	ведомость остатков	выросли — выбор не соответствует вкусам
Ночной интервал, часы	замер дежурного	распорядок «поплыл» обратно

Панель заполняется раз в квартал за один час и ложится на стол директору и в записку учредителю.

Это единственный аргумент, который работает и с проверкой, и с финансированием: собственные числа.

Механика регресса — и противоядие

Шаг 1

Уходит инициатор — заведующая или диетсестра, на которой всё держалось

Шаг 2

Процедура показа меню «временно» упрощается — на неделю, потом навсегда

Шаг 3

Через квартал журнал ведётся «для проверки», выбор снова делает кухня

Противоядие — не энтузиазм, а закрепление: приказ вместо договорённости; ответственный и подменяющий; ротация; квартальная панель; взаимные аудиты с соседним учреждением.

Внешне учреждение при регрессе остаётся «внедрившим» — положение-то действует. Регресс читается в панели чисел раньше, чем в жалобах: падает доля выбирающих, пустеет журнал срывов.

Практика считается устоявшейся, когда пережила смену двух заведующих. До этого рубежа она — проект

Три вопроса, которые вы услышите у себя в регионе

«У нас 400 жителей и поваров нет. Это для маленьких домов».

Масштаб решается парными эквивалентами и журналом заказа — Успенский ПНИ крупный. Кадровый голод реален: ступень 1 на одном отделении требует минимального приращения работы. Если и это не по силам — делаем хорошо ступень 0.

«Жители с тяжёлыми расстройствами не могут выбирать».

Выбор предлагается тем, кто может, — форматом каждому доступным: показ двух тарелок вместо слов, выбор жестом. Кому выбор противопоказан — решает врач, и это пишется в список. «Не выбирают» чаще значит «давно не спрашивали»: навык восстанавливается практикой.

«Если все выберут вариант Б — кто отвечает за срыв?».

Выбор делается накануне через журнал заказа, а не на линии: готовится по заказу плюс резерв, статистика за две недели пересчитывает пропорции. Срывы бывают у всех внедривших — вопрос не «будут ли», а «записываются ли».

Понедельник: десять действий без звонка учредителю

1. Поручить замерить ночной интервал — три дня, три строки в журнале дежурного
2. Проверить температуру на последнем столе — один раз, термометром
3. Завести ведомость остатков — пять цифр в день
4. Завести журнал отказов: отказ → замена по таблице
5. Сверить три списка «кому трудно есть»: врача, диетсестры, отделений
6. Назначить дату первого совета по питанию из жителей
7. Выбрать одну позицию-кандидата на пару «А/Б»
8. Поручить диетсестре вписать пару в таблицу замен
9. Пообедать на последнем столе отделения — и сделать это нормой раз в месяц
10. Назначить ответственного за пилот — и его подменяющего

Ни один пункт не требует денег, согласований и новых штатов. Требуется один подписанный приказ — в конце месяца, а не в понедельник утром.

Определите свою ступень: три вопроса к фактам

1. Покажите вчерашний журнал.

Если выбор не зафиксирован вчера — ступень не выше первой, что бы ни говорило положение.

2. Был ли второй вариант физически на линии вчера?

Спросите смену, сверьте с журналом срывов: «закончился к первому отделению» = доступности нет.

3. Кто из жителей вчера выбрал не то, что принесли бы по умолчанию?

Назовите по имени. Если таких нет третью неделю подряд — выбор декоративен.

Ступень определяется вчерашним днём, а не принятым положением.

Семинарский пакет: 19 инструментов к докладу

Говорить и убеждать

- тексты выступлений на 45 и 20 минут
- записка руководителю (4 страницы)
- раздатка участнику (8–12 страниц)

Проверить себя

- экспресс-аудит на 10 минут
- форма самоопределения ступени
- чек-лист «что в понедельник»
- «10 ошибок вариативного питания»

Работать в зале

- сценарий малых групп на 45 минут
- пять вопросов для дискуссии
- сценарий трудных вопросов
- четырнадцать возражений и ответы

Принимать решения

- «10 вопросов учредителю»
- листы решений: без средств / с финансированием / с учредителем / не без врача
- вопросы для юридического заключения

Доклад — полный текст с обоснованиями (объём — на обложке PDF). Пакет — то, что лежит на столе в понедельник.
Каждый элемент открывается и заполняется без подготовки.

Что подтвердилось в рецензируемой литературе

Япония: по базе LIFE уже вышли исследования. Первый анализ штатных диетологов по национальной базе LIFE (Hori et al., 2025) — система «доплата → охват → стандарт → данные» работает как источник доказательств.

Трапеза — про достоинство, а не только про еду. Модель Maggie Beer (BMC Geriatrics, 2026) в residential aged care и обзор трапезы глазами жителей (Harstäde et al., 2025): организация стола влияет не меньше меню.

IDDSI: персоналу нужна поддержка. Griffin et al. (2024): сотрудники домов ухода применяют шкалу с ошибками без обучения — прямое подтверждение нашего вывода «изменение достигнуто обучением, а не оборудованием».

Вес и саркопения — плановая работа. Обзор прибавки веса на антипсихотиках (Seiter et al., 2025) и метаанализ белковых вмешательств при саркопении (Yoshimura et al., 2025): мониторинг веса и белок — доказанная практика.

Выводы литературы совпадают с тезисом доклада: еда — это выбор и процедура, а не только калорийность нормы.

Кто будет выбирать, что есть житель вашего дома, — завтра?

Сейчас подтверждённых публичных практик — шесть, трое носителей — в этом зале.

Через год панель должна быть не из трёх человек, а из двадцати. У каждой организации в зале есть всё, чтобы стать следующей:

замер → пара на линии или на подносе → если кухня чужая, строка в ТЗ.

Доклад, семинарский пакет и все формы — в материалах семинара. Вопросы после сессии: [контакт докладчика].

Благодарю за вчерашние журналы, которые вы заведёте в понедельник.